



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA
MANAJEMEN RISIKO**

SEMESTER I

**RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
SUKOREJO**

TAHUN 2025

Jl. Raya Surabaya – Malang No. KM 54, Surabaya – Pasuruan

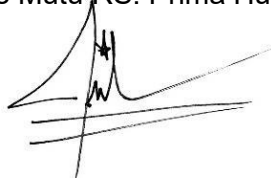
Telp. 08341 – 67

LEMBAR PENGESAHAN

**Laporan Kinerja Manajemen Resiko
Rumah Sakit Prima Husada
Sukorejo**

Laporan Kinerja Manajemen risiko merupakan metode penanganan sistematis formal dimana dikonsentrasikan pada pengidentifikasian dan pengontrolan peristiwa atau kejadian yang memiliki kemungkinan perubahan yang tidak diinginkan.

Disusun,
Oleh :
Komite Mutu RS. Prima Husada



(Lidia Puspita Kencana, S.KM.)

Disetujui oleh,
Authorized Person



(Dr.dr.Aslichah M.Kes., AFP)

Disetujui Oleh :
Direktur RS. Prima Husada



(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, SWT karena atas Rahmat-Nya Evaluasi Kinerja Manajemen Resiko Semester I pada Tahun 2025 telah dapat diselesaikan. Evaluasi kinerja ini digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengurangi cedera dan mengurangi risiko lain terhadap keselamatan pasien dan staf di Unit Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Rumah sakit yang menerapkan prinsip keselamatan pasien berkewajiban untuk mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko strategis dan operasional yang penting. Hal ini mencakup seluruh area baik manajerial maupun fungsional, termasuk area pelayanan, tempat pelayanan, juga area klinis. Rumah sakit perlu menjamin berjalannya sistem untuk mengendalikan dan mengurangi risiko. Manajemen risiko berhubungan erat dengan pelaksanaan keselamatan pasien rumah sakit dan berdampak kepada pencapaian sasaran mutu rumah sakit. Ketiganya berkaitan erat dalam suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya program manajemen risiko ini diharapkan dapat menjadikan sebuah pendekatan proaktif untuk membantu Rumah Sakit untuk memperbaiki, mengambil keputusan untuk keseimbangan optimal antara risiko, keuntungan dan biaya.

Akhir kata, kami dari Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya evaluasi kinerja Manajemen Resiko Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Semester I pada Tahun 2025.

Penyusun

Komite Mutu

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
Laporan Kinerja Manajemen Resiko Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo .	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan Umum	6
1.3.3 Tujuan Khusus	6
BAB IIGAMBARAN UMUM	7
2.1. Visi	7
2.2. Misi	7
2.3. Motto	7
2.4. 7 Nilai Budi Utama	7
BAB III	8
KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI	8
3.1 SDM	8
3.1.1 Kebutuhan SDM	8
3.1.2 Orientasi	8
3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	8
3.2. Pengembangan Pelayanan	11
3.3 Kinerja Produktifitas Manajemen Risiko	12
3.3.1 Profil Risiko	12
3.2 Rencana Penanganan Risiko	13
BAB IVMONITORING DAN EVALUASI	15
4.1 Pemantauan dan Pengendalian Risiko	15
4.2 Hasil Pemantauan	16
4.2.1 Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran	16
4.2.2 Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal	16
BAB VPENUTUP	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang padat modal, padat teknologi, dan padat karya, serta memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi. Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif, rumah sakit dihadapkan pada berbagai potensi risiko. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko klinis (terkait keselamatan pasien), risiko non-klinis/fasilitas, risiko finansial, risiko hukum, hingga risiko reputasi. Kegagalan dalam mengelola risiko ini tidak hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa manusia.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (STARKES), setiap rumah sakit diwajibkan menerapkan tata kelola mutu dan keselamatan pasien yang komprehensif. Salah satu pilar utamanya adalah implementasi manajemen risiko yang terintegrasi di tingkat rumah sakit. Standar STARKES menuntut rumah sakit tidak hanya sekedar mengidentifikasi risiko, melainkan mampu melakukan mitigasi secara proaktif dan berkelanjutan demi menciptakan pelayanan yang aman (*safe*), efektif, dan berpusat pada pasien (*patient-centered care*).

Sebagai institusi yang berkomitmen terhadap mutu pelayanan, Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo telah menjalankan program manajemen risiko di seluruh unit kerja. Namun, efektivitas dari program tersebut tidak dapat diukur tanpa adanya evaluasi yang terstruktur terhadap hasil-hasil mitigasi yang telah dilakukan. Evaluasi ini krusial untuk mengetahui apakah tindakan korektif dan preventif yang telah diambil berhasil menurunkan derajat risiko (*risk level*) atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Oleh karena itu, Laporan Kinerja Manajemen Risiko Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo ini disusun. Laporan ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi formal yang memotret hasil mitigasi risiko di tingkat rumah sakit. Melalui laporan ini, manajemen dapat mengidentifikasi celah (*gap*) pelayanan, menentukan prioritas perbaikan, dan memastikan bahwa seluruh operasional Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo berjalan sesuai dengan standar akreditasi STARKES demi mewujudkan visi dan misi rumah sakit yang berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

- 1.2.1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 1.2.3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
- 1.2.4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
- 1.2.5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
- 1.2.6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0107/Menkes/1354/2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko
- 1.2.7. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/1596 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi RS
- 1.2.8. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 635.1/DPM/I-KEP/DIR/XII/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Prima Husada
- 1.2.9. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1041.21/DPM/I-KEP/DIR/VII/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Manajemen Risiko ini adalah sebagai dokumen pertanggungjawaban penjaminan mutu (*quality assurance*) dan instrumen evaluasi formal untuk menilai efektivitas pelaksanaan program manajemen risiko yang telah diimplementasikan di RS Prima Husada Sukorejo

1.3.2 Tujuan Umum

Menurunkan atau mengeliminasi potensi risiko di seluruh lini pelayanan dan operasional Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo guna memastikan terciptanya lingkungan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu tinggi, dan memenuhi standar akreditasi STARKES

1.3.3 Tujuan Khusus

1. Mengevaluasi Efektivitas Mitigasi: Menilai sejauh mana tindakan korektif dan preventif yang telah dijalankan mampu menurunkan tingkat risiko (risk level) di RS Prima Husada Sukorejo
2. Memetakan Profil Risiko Terbaru: Memperbarui data daftar risiko (risk register) rumah sakit berdasarkan evaluasi berkala dan perkembangan kondisi operasional terkini
3. Menjamin Kepatuhan Standar STARKES: Memastikan pemenuhan elemen penilaian akreditasi STARKES, khususnya terkait regulasi tata kelola, manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK), serta keselamatan pasien
4. Menjadi Dasar Pengambilan Keputusan: Memberikan rekomendasi strategis bagi Direksi dan Manajemen RS Prima Husada Sukorejo dalam mengalokasikan sumber daya untuk perbaikan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement)
5. Meningkatkan Budaya Keselamatan (Safety Culture): Mendorong kesadaran dan keterlibatan aktif seluruh civitas hospitalia dalam melaporkan, menganalisis, dan memitigasi risiko di unit kerja masing-masing

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1. Visi

Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.

2.2. Misi

- 1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat.
- 2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
- 3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

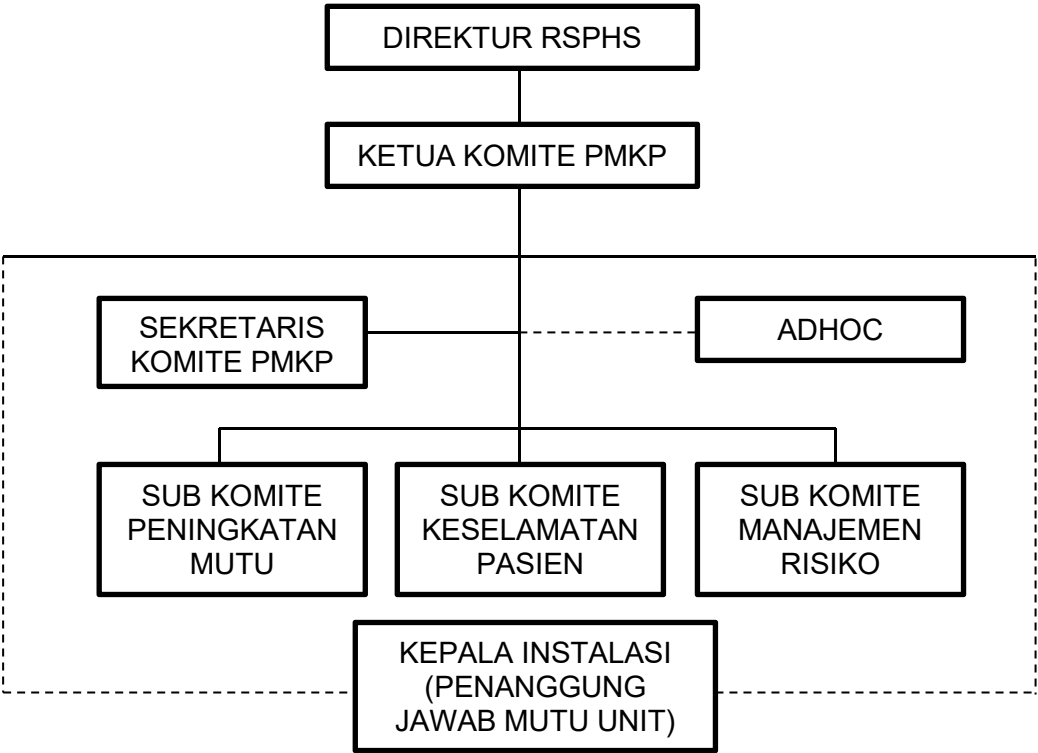
2.3. Motto

Sahabat Menuju Sehat

2.4. 7 Nilai Budi Utama

- 1. Jujur + Dipercaya
- 2. Tanggung Jawab
- 3. Visioner
- 4. Disiplin
- 5. Kerja sama
- 6. Adil
- 7. Peduli

2.5 SOTK Manajemen Risiko



BAB III
KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

3.1 SDM
3.1.1 Kebutuhan SDM

Implementasi program manajemen risiko yang komprehensif di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan terstruktur secara berjenjang. Pengelolaan risiko tidak bertumpu pada satu individu, melainkan dijalankan secara kolaboratif melalui koordinasi terintegrasi. Di tingkat korporat, kendali program berada di bawah Komite Mutu, khususnya Subkomite Manajemen Risiko, yang berfungsi sebagai motor penggerak. Tim ini diperkuat oleh tenaga kesehatan atau profesional manajemen yang telah memiliki sertifikasi keahlian dalam manajemen risiko rumah sakit (*Certified Risk Management*), yang bertugas menyusun strategi makro, menganalisis data agregat, serta menyusun laporan evaluasi ini untuk disampaikan kepada Direktur.

Untuk memastikan program berjalan di setiap lini pelayanan, rumah sakit menunjuk Person in Charge (PIC) Manajemen Risiko di setiap instalasi dan unit kerja, seperti ruang rawat inap, IGD, kamar operasi, farmasi, hingga unit non-klinis seperti K3RS dan IPSRS. Para PIC unit ini umumnya merupakan kepala ruangan atau staf senior yang memahami alur kerja operasional sehari-hari di areanya masing-masing. Mereka bertanggung jawab langsung dalam mengidentifikasi potensi bahaya di unit, mengawal implementasi mitigasi yang telah disepakati, serta melakukan pelaporan berkala terhadap insiden atau risiko baru yang muncul di lapangan.

Selain pemenuhan struktur organisasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM menjadi prioritas utama guna menjamin validitas hasil evaluasi dalam laporan ini. Seluruh jajaran pengelola risiko, baik di tingkat komite maupun unit, dibekali dengan pelatihan berkala terkait keselamatan pasien (*patient safety*), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), serta penguasaan instrumen analisis risiko formal seperti Risk Grading Matrix, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), dan Root Cause Analysis (RCA). Melalui sinergi SDM yang kompeten dan terstruktur ini, Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo optimis dapat terus menekan tingkat risiko operasional sejalan dengan pemenuhan standar akreditasi STARKES.

3.1.2 Orientasi
Belum ada orientasi pada staf baru.

3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
1. Peserta Yang Mengikuti Tes Teori

No	Sasaran	Jumlah				Presentasi peserta
		Peserta Diundang	Peserta yang Mengerjakan		Peserta yang tidak mengerjakan pre & post	
			Pre Test	Post Test		
1	Cleaning Service	41	32	32	9	78,05%
2	Pantry	4	4	4	0	100%
3	Security	11	11	9	0	100%
4	Pendaftaran	19	17	17	2	89,47%
5	Driver	7	4	1	3	57,14%
6	Atem	2	2	2	0	100%
7	IPSRS	4	3	3	1	75%
8	Rekam Medis	9	8	8	1	88,89%
9	Asuransi Center	12	12	12	0	100%
10	Kasir	10	10	9	0	100%
11	Dapur	10	9	8	1	90%

No	Sasaran	Jumlah				Presentasi peserta
		Peserta Diundang	Peserta yang Mengerjakan		Peserta yang tidak mengerjakan pre & post	
			Pre Test	Post Test		
12	Laundry	6	5	3	1	83,33%
13	CSSD	4	4	4	0	100%
14	Radiologi	7	4	3	3	57,14%
15	Gizi	6	6	6	0	100%
16	Farmasi	47	43	43	4	91,49%
17	Laboratorium	12	10	10	2	83,33%
18	Gudang Umum	1	1	1	0	100%
19	IT & SIMRS	3	3	3	0	100%
20	Humas & Marketing	2	2	2	0	100%
21	IKO	13	6	3	7	46,15%
22	IRJA	29	18	15	11	62,07%
23	IGD	30	11	8	19	36,67%
24	IRNA 2A	26	20	18	6	76,92%
25	IRNA 2B	24	11	10	13	45,83%
26	MOD-MPP-PIPP	5	5	5	0	100%
27	IRNA 3A	21	19	16	2	90,48%
28	IRNA 3B	17	17	12	0	100%
29	ICU	12	11	11	1	91,67%
30	Neonatologi & NICU	12	12	12	0	100%
31	Maternitas	14	13	11	1	92,86%
32	Sekretariat	7	6	6	1	85,71%
Total		427	339	307	88	85,07%

Tes teori pelatihan PMKP dilakukan melalui kuesioner dengan media google formulir. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Tahun 2025 diikuti oleh berbagai unit kerja di rumah sakit dengan total peserta yang diundang sebanyak 427 orang. Dari total 427 peserta yang diundang, hanya 339 peserta (79,39%) yang mengikuti pre test dan 307 peserta (71,89%) yang menyelesaikan post test. Sebanyak 88 peserta (20,61%) tidak mengikuti pre maupun post test, yang berpotensi menurunkan capaian evaluasi pelatihan secara keseluruhan.

Beberapa unit yang menunjukkan partisipasi 100% yaitu pantry, security, atem, Asuransi center, CSSD, Gizi, Gudang Umum, IT, Humas & Marketing, MOD, IRNA 3B dan Neonatologi-NICU. Unit-unit ini menunjukkan komitmen penuh terhadap program pelatihan, dan dapat dijadikan contoh pengelolaan SDM yang baik dalam mendukung mutu dan keselamatan pasien.

Adapun unit dengan partisipasi rendah seperti IGD 36,67%, IKO 46,15%, IRNA 2B 45,83%, IRJA 62,07%. Unit-unit ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari tim manajemen untuk mengevaluasi hambatan partisipasi seperti jadwal, dan beban kerja.

2. Peserta Yang Megikuti Tes Praktek

No	Sasaran	Jumlah			Presenatasi Kehadiran
		Peserta Diundang	Peserta Hadir	Peserta Tidak Hadir	

No	Sasaran	Jumlah			Presenatasi Kehadiran
		Peserta Diundang	Peserta Hadir	Peserta Tidak Hadir	
1	Cleaning Service	41	41	0	100%
2	Pantry	4	4	0	100%
3	Security	11	10	1	90,91%
4	Pendaftaran	19	15	4	78,95%
5	Driver	7	1	6	14,29%
6	Atem	2	2	0	100%
7	IPSRs	4	4	0	100%
8	Rekam Medis	9	8	1	88,89%
9	Asuransi Center	12	12	0	100%
10	Kasir	10	10	0	100%
11	Dapur	10	1	9	10%
12	Laundry	6	4	2	66,67%
13	CSSD	4	4	0	100%
14	Radiologi	7	2	5	28,57%
15	Gizi	6	6	0	100%
16	Farmasi	47	40	7	85,11%
17	Laboratorium	12	10	2	83,33%
18	Gudang Umum	1	1	0	100%
19	IT & SIMRS	3	3	0	100%
20	Humas & Marketing	1	1	0	100%
21	IKO	13	12	1	92,31%
22	IRJA	29	13	16	44,83%
23	IGD	30	15	15	50%
24	IRNA 2A	26	22	4	84,62%
25	IRNA 2B	24	16	8	66,67%
26	MOD-MPP-PIPP	5	5	0	100%
27	IRNA 3A	21	18	3	85,71%
28	IRNA 3B	17	11	6	64,71%
29	ICU	12	8	4	66,67%
30	Neonatologi & NICU	12	12	0	100%
31	Maternitas	14	10	4	71,43%
32	Sekretariat	7	6	1	85,71%
Total		426	327	99	76,76%

Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Tahun 2025 diikuti oleh berbagai unit kerja di rumah sakit dengan total peserta yang diundang sebanyak 426 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 327 peserta hadir, sedangkan 99 peserta tidak hadir, dengan tingkat kehadiran keseluruhan mencapai 76,76%.

Unit dengan Kehadiran 100% yakni Cleaning Service, Pantry, Atem IPSRS,

Asuransi Center, Kasir, CSSD, Gizi, Gudang Umum, IT & SIMRS, Humas & Marketing, MOD-MPP-PIPP dan Neonatologi-NICU. Hal ini menunjukkan komitmen penuh dari unit-unit tersebut terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Unit dengan kehadiran <50% yang perlu menjadi perhatian untuk kegiatan pelatihan berikutnya yakni Dapur 10%, Driver 14,29%, Radiologi 28,57%, IRJA 44,83%, dan IGD 50%. Rendahnya kehadiran dari beberapa unit ini dapat disebabkan oleh faktor operasional atau jadwal kerja yang padat dan perlu dikaji lebih lanjut untuk perbaikan pada pelatihan mendatang.

Secara umum, pelatihan ini mendapatkan respon yang cukup baik yakni 76,76% peserta yang hadir. Adapun 23,24% peserta yang tidak hadir akan dijadwalkan ulang. Meskipun begitu, beberapa unit masih perlu peningkatan dalam hal partisipasi, agar pelatihan dapat merata dan berdampak optimal di seluruh unit pelayanan rumah sakit.

1. Hasil Pre Dan Post Test

a. Hasil Pre dan Post Test Teori

No	Skor Nilai		Jumlah Peserta			
	Kategori	Nilai	Pre Test	Presentase	Post Test	Presentase
1	Lulus	80 – 100	209	61,65%	271	88,27%
2	Tidak Lulus	<80	130	38,35%	36	11,73%
Jumlah			339	100%	307	100%

Terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman teori setelah dilakukan intervensi atau pelatihan. Jumlah peserta lulus meningkat sebanyak 62 orang (dari 209 ke 271) dan Persentase kelulusan meningkat sebesar 26,62%. Jumlah peserta tidak lulus menurun sebanyak 94 orang (dari 130 ke 36) dan Persentase tidak lulus menurun sebesar 26,62%. Metode pembelajaran atau pelatihan yang diberikan terbukti efektif dalam meningkatkan capaian pengetahuan peserta. Tingginya angka kelulusan pada post-test menunjukkan bahwa mayoritas peserta mampu menyerap materi dengan baik.

b. Hasil Pre dan Post Test Praktek

No	Skor Nilai		Jumlah Peserta			
	Kategori	Nilai	Pre Test	Presentase	Post Test	Presentase
1	Lulus	80 – 100	146	44,65%	313	95,72%
2	Tidak Lulus	<80	181	55,35%	14	4,28%
Jumlah			327	100%	327	100%

Terdapat peningkatan kelulusan peserta setelah pelatihan, kenaikan jumlah peserta yang lulus dari 146 menjadi 313 orang (naik 167 orang atau 114,38%). Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan efektif meningkatkan pengetahuan peserta, yang tercermin dari meningkatnya presentase kelulusan setelah pelatihan berlangsung.

3.2. Pengembangan Pelayanan

3.3 Kinerja Produktifitas Manajemen Risiko

3.3.1 Profil Risiko

No	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Akar Masalah (Penyebab Utama Risiko)	Dampak (D)	Probabilitas (P)	Controllability	Bobot	Rangking
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (5x6)	(8) (5x6)	(9)
1	Risiko Non Klinis	Karena tidak bekerja dengan hati-hati dan tidak sesuai SPO Risiko terjadinya cedera pada pasien selama tindakan operasi akibat penggunaan alat kedokteran (harum pen) yang tidak aman atau tidak sesuai prosedur	Karena alat harum pen dikirimkan dengan batch yang berbeda dari biasanya	3	4	12	1,3	1
2	Risiko Non Klinis	Terdapat risiko maintenance alat medis tidak dilaksanakan sesuai jadwal sehingga alat mengalami penurunan fungsi atau kerusakan yang dapat mengganggu pelayanan operasi dan meningkatkan risiko keselamatan pasien.	Belum optimalnya sistem perencanaan, pemantauan, dan koordinasi pelaksanaan preventive maintenance alat medis	3	3	9	1,43	2

Keterangan Controlability (Pengendalian) :

- 1 : easy (mudah untuk dikontrol)
- 2 : moderate easy (agak mudah dikontrol)
- 3 : moderate difficult (agak sulit dikontrol)
- 4 : difficult (sulit untuk dikontrol)

3.2 Rencana Penanganan Risiko

No	Kegiatan	Sasaran	Resiko (Prioritas / Sangat Tinggi)	Alternatif Teknik Penanganan Resiko		Pengendalian Yang Sudah Ada			Rencana Pengendalian			Pemilik Resiko	Penanggung Jawab TL Pengendalian
				Opsi Teknik Penanganan Resiko	Uraian Penanganan Resiko	Pengendalian yang sudah ada	Efektif / Kurang Efektif	Pengendalian yang harus ada	Kegiatan	Waktu	Jenis (Detektif (D), Preventif (P), Korektif (K))		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pelayanan tindakan operasi di kamar operasi	Mencegah terjadinya cedera pada pasien akibat penggunaan alat kedokteran selama tindakan operasi (target: 0 kejadian).	Pasien mengalami cedera akibat alat kedokteran, tidak berfungsi dengan baik, atau digunakan tidak sesuai prosedur	Mitigasi/Pengurangan Risiko	Memastikan alat kedokteran (harum pen) aman dan layak digunakan sebelum operasi	SOP penggunaan alat, pemeriksaan alat sebelum operasi, sterilisasi alat, Surgical Safety Checklist.	Kurang efektif (apabila masih terdapat insiden atau <i>near miss</i>)	Checklist kelayakan alat sebelum operasi, preventive maintenance, kalibrasi berkala, pelatihan penggunaan alat, audit kepatuhan SOP, sistem pelaporan insiden.	Pemeriksaan fungsi dan kelayakan alat sebelum tindakan operasi	Setiap hari sebelum operasi	Preventif (P)	Kepala Instalasi Bedah Sentral (IBS)/Kepala Kamar Operasi.	Koordinator Kamar Operasi, dan Penanggung Jawab Pemeliharaan Alat Elektromedis (IPSRS/Unit Elektromedis)
2	Pemeliharaan (maintenance) alat medis di Instalasi Kamar Operasi (IKO).	Tercapainya kepatuhan maintenance alat medis sesuai jadwal sebesar 100% sehingga seluruh alat siap digunakan dengan aman.	Ketidakpatuhan pelaksanaan maintenance alat medis sesuai jadwal di IKO sehingga alat berpotensi tidak layak pakai, tidak akurat, atau mengalami	Mitigasi/Pengurangan Risiko	Memastikan seluruh alat medis menjalani preventive maintenance sesuai jadwal.	Jadwal maintenance tahunan, pencatatan riwayat pemeliharaan, koordinasi dengan IPSRS/Unit Elektromedis, pelaporan kerusakan alat.	Kurang efektif apabila masih terdapat alat yang terlambat menjalani maintenance.	Sistem pengingat (reminder) jadwal maintenance, monitoring kepatuhan bulanan, daftar alat yang akan jatuh tempo, audit kepatuhan, dan tindak lanjut	- Menyusun dan memperbarui jadwal preventive maintenance - Melaksanakan maintenance sesuai jadwal	- Awal tahun dan bila ada alat baru - Sesuai jadwal masing-	Preventif (P)	Kepala Instalasi Kamar Operasi (IKO)/Kepala Instalasi Bedah Sentral (IBS).	Kepala IPSRS/Unit Elektromedis, Teknisi Elektromedis, Koordinator Kamar Operasi, Penanggung Jawab Alat Medis, dan

			kerusakan saat digunakan dalam tindakan operasi					segera terhadap alat yang terlambat maintenance.		masi ng alat			Kepala IKO.
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--------------------	--	--	-------------

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

4.1 Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Kegiatan : Pelayanan tindakan operasi di kamar operasi

Sasaran Kegiatan : Mencegah terjadinya cedera pada pasien akibat penggunaan alat kedokteran (harum pen) selama tindakan operasi

No	Risiko (Prioritas)	Penanganan			Usulan perbaikan	Waktu pemantauan		PJ Pemantauan
		Rencana	Realisasi	Yang belum tertangani		Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran	Pemeriksaan fungsi alat sebelum setiap dilaksanakan operasi.	Pemeriksaan alat telah dilakukan sebelum operasi.	Alat sudah diganti dengan batch yang sebelumnya digunakan .	Tetap menggunakan harum pen dengan batch yang sesuai (sticky pen)	Setiap hari sebelum tindakan operasi	Setiap hari	Kepala Ruang IKO

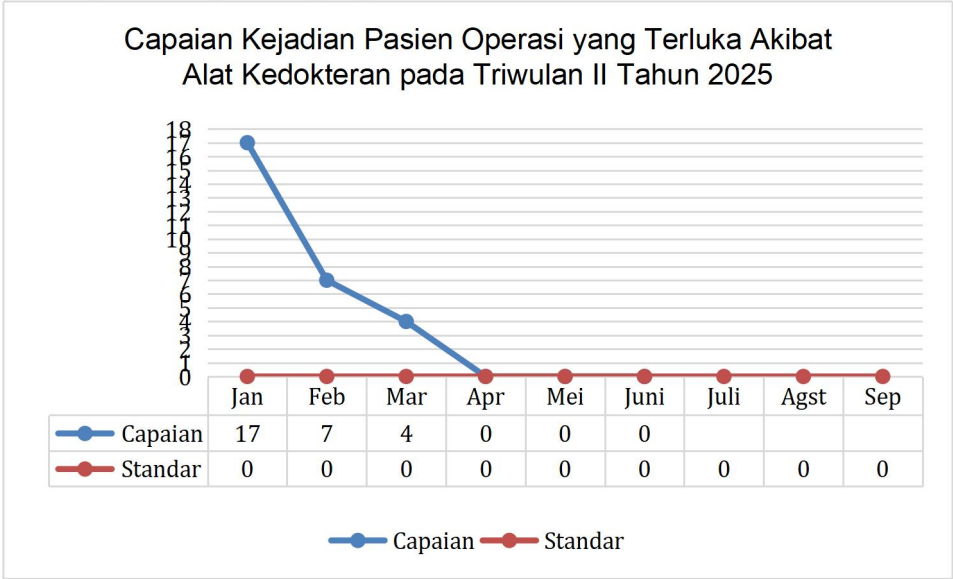
Kegiatan : Pemeliharaan (maintenance) alat medis di Instalasi Kamar Operasi (IKO).

Sasaran Kegiatan : kepatuhan maintenance alat medis sesuai jadwal sebesar **100%** sehingga seluruh alat siap digunakan dengan aman.

No	Risiko (Prioritas)	Penanganan			Usulan perbaikan	Waktu pemantauan		PJ Pemantauan
		Rencana	Realisasi	yang belum tertangani		Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Keterlambatan preventive maintenance menyebabkan alat tidak siap digunakan saat operasi.	Preventive maintenance dilakukan sesuai jadwal bulanan.	100% alat telah dilakukan Preventive maintenance dilakukan sesuai jadwal.	Program maintenance alat medis di IKO berjalan optimal dan sesuai dengan jadwal	Tetap melakukan Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal	Mingguan dan bulanan.	Monitoring dilakukan setiap minggu, laporan bulanan..	Kepala Instalasi Kamar Operasi (IKO) bersama Kepala/Koordinator IPSRS atau Unit Elektromedis

4.2 Hasil Pemantauan

4.2.1 Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran

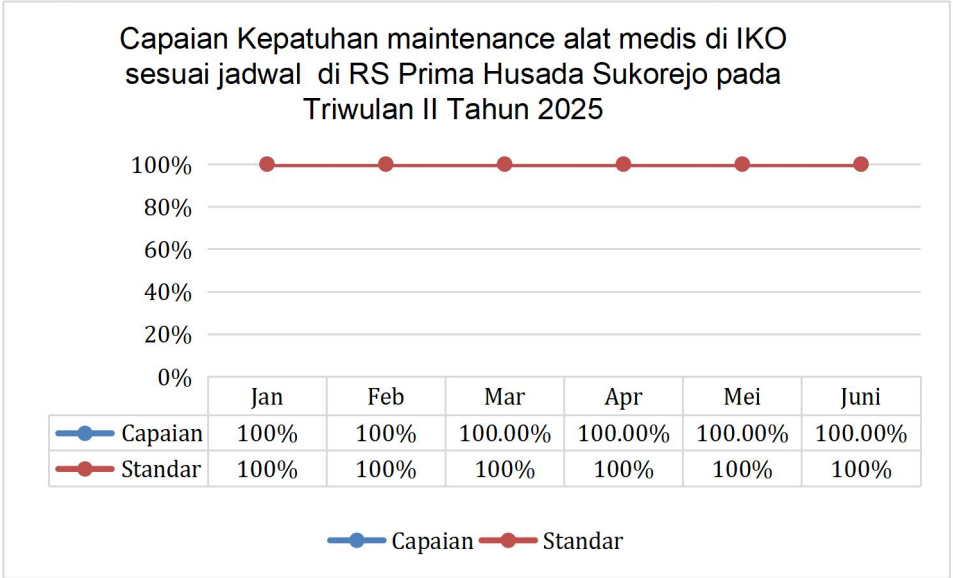


Gambar 1. Capaian Kejadian Pasien Operasi yang Terluka Akibat Alat Kedokteran di RS Prima Husada Sukorejo pada Semester I Tahun 2025

Analisis :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran di RS Prima Husada Sukorejo yakni 0 kejadian. Pada bulan Maret 2025, telah dilakukan pergantian alat kedokteran, khususnya harum pen. Dampak positifnya pada Bulan April dan Triwulan II Tahun 2025 yakni menurunnya risiko cedera pada pasien operasi, dan meningkatkan kinerja tim bedah dan sterilisasi karena alat sudah memenuhi standar.

4.2.2 Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal



Gambar 2. Capaian Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal di RS Prima Husada Sukorejo pada Semester I Tahun 2025

Analisa :

Berdasarkan hasil rata-rata capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 capaian Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yakni 100%. Angka tersebut sudah mencapai target 100%. Kepatuhan 100% menunjukkan bahwa program maintenance alat medis di IKO berjalan optimal dan sesuai dengan jadwal. Tidak ditemukan keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan preventive maintenance maupun kalibrasi alat-alat kritis

BAB V PENUTUP

Demikian laporan manajemen resiko RS Prima Husada Sukorejo Semester I Tahun 2025, semoga dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana penanganan yang dilakukan

Pasuruan, 31 Juni 2025

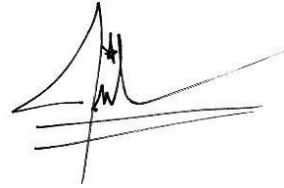
Menyetujui,
Direktur Rumah Sakit Prima
Husada Sukorejo



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
SUKOREJO

(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS)

Penyusun Ketua Komite Mutu



(Lidia Puspita Kencana, S.KM.)

